10. IL CUORE : SVILUPPO DELL'ANATOMIA ARTERIOSA

DURATA : 04:14 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nel cuore dello sviluppo embrionale delle cellule sanguigne, descrivendone l'origine dalla vescicola ombelicale fino al midollo osseo. Si esplora anche la persistenza dell'arteria mesenterica, un residuo vitale di questo processo, e il suo ruolo nello sviluppo intestinale. L'arco aortico è messo in evidenza per illustrare il movimento ritmico del cuore e il suo impatto sulla circolazione sanguigna. Associando le dinamiche cardiache all'ambiente fasciale che mantiene le strutture vitali come l'esofago e i bronchi, il video rivela come gli squilibri in questa zona ritmica possano influenzare patologie cardiologiche e muscoloscheletriche. Una lezione essenziale per ogni terapeuta interessato alle interconnessioni corporee.

IL CUORE: SVILUPPO DELL'ANATOMIA ARTERIOSA

ORIGINE E SVILUPPO DELLE CELLULE SANGUIGNE

Le prime **cellule sanguigne** appaiono intorno al **18° giorno** di sviluppo embrionale. La loro origine si articola in tre fasi importanti.

Inizialmente, provengono dalla **vescicola ombelicale**, dove si trovano i **megaloblasti primitivi**. Questa fase dura i primi due mesi.

Fin dall'inizio del **secondo mese**, un secondo movimento di produzione sanguigna emerge dal **fegato**.

È solo intorno al **terzo mese** che una parte di questa produzione inizia a verificarsi a livello del **midollo osseo**.

Si può osservare qui uno sviluppo dalla periferia al centro: prima il periodo **ombelico-peduncolare**, poi il periodo **epatico**, e infine il midollo osseo per i **globuli rossi**.

IL VESTIGIO DELLO SVILUPPO VITELLINO: L'ARTERIA MESENTERICA

L'unico vestigio che rimarrà di questo sviluppo vitellino è l'**arteria mesenterica**.

Essa fungeva da asse di rotazione, un **fulcro**, per la rotazione e lo sviluppo dell'**ansa intestinale**.

Nel momento in cui la **cavità amniotica** si forma tutt'intorno, la vescicola vitellina, che contiene le cellule originali per la circolazione, si reintegra.

Per una parte, con la vescicola vitellina, il **peduncolo embrionale** formerà il **colon ombelicale** con la placenta. Il vestigio che si collegherà è il **sistema mesenterico** (la vescicola superiore). Questo asse di rotazione è cruciale per lo sviluppo embrionale.

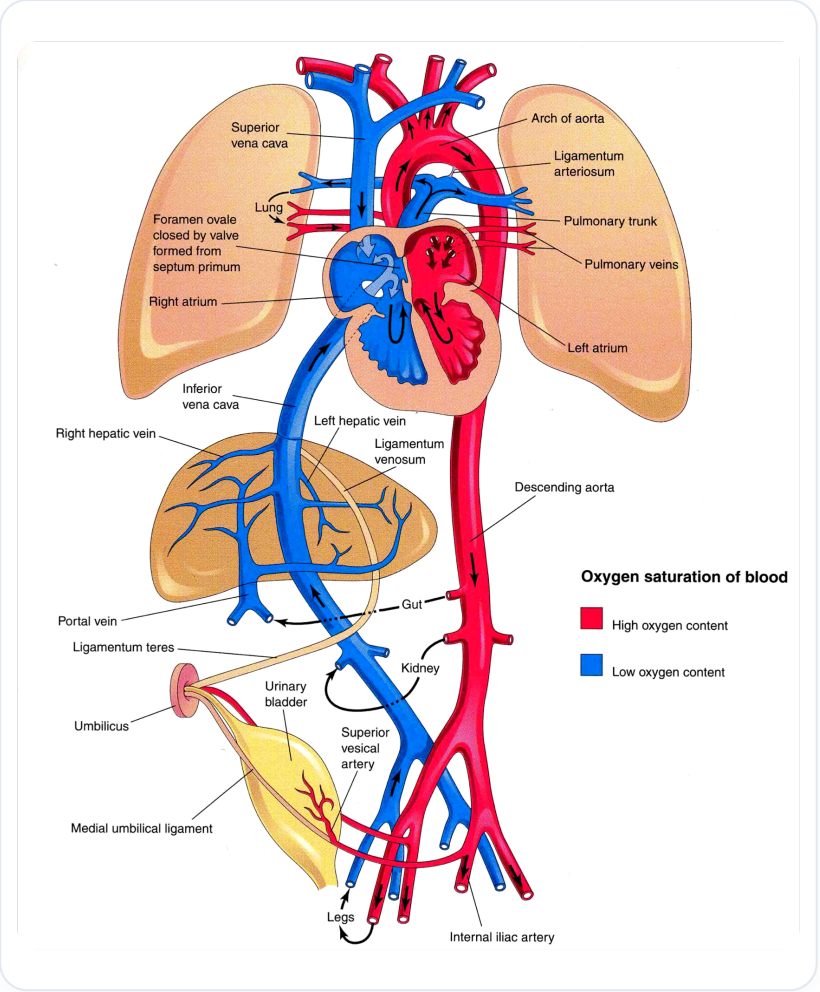


FIG. — Circolazione fetale umana

IL MOVIMENTO DEL CUORE E DELL'ARCO AORTICO

Quando si osserva il cuore, si vede l'**arco dell'aorta**. Simbolicamente, si può dire che sale o che scende.

Questo movimento dell'arco aortico rappresenta il **battito del cuore**. Riproduce quasi un movimento di sviluppo.

L'arco dell'aorta compie un movimento di **torsione** o di **detorsione** durante il ciclo cardiaco.

Nel momento in cui il cuore spinge, l'arco dell'aorta si apre per assorbire il sangue. Nel momento in cui il cuore si svuota, si chiude compiendo un movimento particolare.

Si apre per prendere il sangue e si chiude per espellerlo, il che collega intrinsecamente l'arco dell'aorta alla funzione del cuore.

L'ARCO AORTICO E IL CICLO CARDIACO

È un po' come un giocatore di **pallacanestro**. Nel momento in cui il cuore sale, è lì che l'aorta espelle il suo volume sanguigno.

Bisogna sapere che l'aorta contiene nel suo volume sanguigno quasi tanto sangue quanto il cuore a livello arterioso.

Ciò significa che l'aorta partecipa attivamente all'**eiezione sistolica** del sangue.

Questo è sostenuto dall'**ambiente fasciale**, che si potrebbe paragonare a una **"fishnet stocking"** (calza a rete).

LA ZONA RITMICA: UN INCROCIO FASCIALE VITALE

L'arco dell'aorta, la **biforcazione bronchiale** e l'**esofago** sono collegati da una **fascia** comune, che li tiene uniti.

Questa zona, caratterizzata dalla biforcazione bronchiale, è ciò che viene chiamato il **punto della zona ritmica**.

Consideriamo i ritmi vitali: **100.000 battiti cardiaci** in 24 ore, **23.000 respirazioni** in 24 ore e **1.000-2.000 deglutizioni**.

È una grande zona ritmica che si unisce e si attacca tra **D3**, **D4** e **D5**. Queste vertebre formano un piano di equilibrio fasciale per la zona ritmica, che è allo stesso tempo **cardio**, **pleuro** e **digestiva**.

Abbiamo l'aorta, il cuore, e in basso, una biforcazione molto importante: le **arterie iliache**. In alto, c'è ancora un altro livello.

In realtà, tutto questo forma un piano unitario e puro. Si constata che alcune patologie di tipo **coxo-femorale** o altre possono destabilizzare il cuore. Viceversa, ciò che accade in queste fasi di rotazione può manifestarsi fino al livello del cuore.

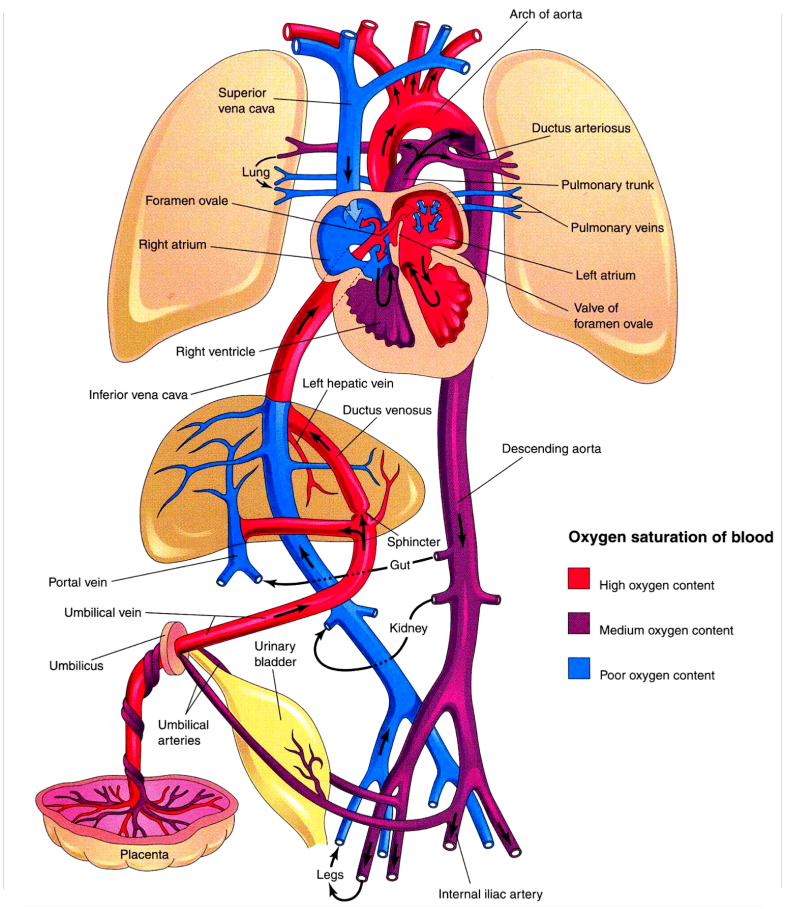


FIG. — Circolazione fetale